UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

CENTRO EQUESTRE: EQUOTERAPIA E BEM-ESTAR ANIMAL

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, (SC)

2026

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ - UNIVALI

AC3 TFG I

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, (SC)

2026

SUMÁRIO

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO....3
2 JUSTIFICATIVA....4
3 OBJETIVOS....6
3.1 Objetivo Geral 6
3.1.2 Objetivos Específicos 6
4 RECORTE DA REVISÃO DA LITERATURA....7
5 CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA 8
5.1 Equoterapia 8
5.2 Desenho universal....8
5.3 Bem-estar animal 8
5.4 Articulação: ambiente co-terapêutico 9
6. SÍNTESE INTERPRETATIVA....10
7. DIAGRAMA CONCEITUAL 11
REFERÊNCIAS....12

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DO FENÔMENO

A busca por estratégias de cuidado, inclusão e reabilitação de pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento tem ampliado as discussões sobre a qualidade dos ambientes destinados às práticas terapêuticas. Nesse contexto, a arquitetura voltada à saúde e à inclusão assume papel relevante ao considerar não apenas a acessibilidade física, mas também as diferentes necessidades sensoriais e funcionais dos usuários.

A equoterapia consolidou-se como método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação. Voltado ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência ou com necessidades especiais (ANDE-BRASIL), foi regulamentada no Brasil pela Lei n° 13.830/2019 (BRASIL, 2019). O público infantil ganha destaque nesse contexto, o Censo Demográfico 2022 registrou 2,4 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista, com maior prevalência entre crianças de 5 a 9 anos (IBGE, 2025).

Apesar desse cenário, muitos centros equoterápicos funcionam em estruturas adaptadas de haras, hípicas ou quartéis, concebidas para manejo do animal ou para esporte, e não para as necessidades sensoriais de quem pratica (KUNTZEL, 2025). Segundo Mostafa (2014) iluminação, som e organização espacial interferem diretamente na participação das crianças. Assim, o espaço deveria apoiar a terapia, muitas vezes se torna uma barreira.

Diante deste cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um Centro de Equoterapia Inclusiva para crianças e jovens, no qual a arquitetura atue como parte do processo terapêutico, conciliando o bem-estar do praticante e do cavalo.

2 JUSTIFICATIVA

A demanda por espaços destinados ao cuidado, à reabilitação e à inclusão de crianças e jovens com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento evidencia a necessidade de ambientes capazes de atender diferentes condições físicas, cognitivas e sensoriais. No Brasil, essa discussão ocorre em um contexto no qual a legislação estabelece a acessibilidade e o desenho universal como condições para o exercício de direitos, autonomia e participação social (BRASIL, 2015). Nesse sentido, pensar em equipamentos especializados que acolham diferentes formas de interação com o ambiente representa não apenas uma questão de saúde, mas também de inclusão e acesso aos serviços oferecidos pela cidade.

Em Santa Catarina, a ANDE-BRASIL registra 15 centros filiados (ANDE-BRASIL, 2026), número reduzido diante dos 295 municípios do estado. Diante disso, há necessidade de ampliar e qualificar espaços destinados à saúde, reabilitação e convivência, considerando sua inserção e relação com o território. Devem promover condições de acesso, integração e permanência, ao mesmo tempo em que demandam características específicas de implantação, principalmente no caso da equoterapia, que necessita conciliar áreas terapêuticas, espaços abertos, contato com a natureza e instalações adequadas aos cavalos.

A terapia apresenta resultados positivos, a qualidade do lugar onde ela acontece também importa. A arquitetura da saúde demonstra isso, como nos hospitais da Rede Sarah, Lelé fez da luz natural, da ventilação e dos jardins parte do processo de reabilitação (LIMA, 2012). Estudos também apontam que o contato com ambientes naturais pode favorecer a redução do estresse e o bem-estar dos usuários. (KAPLAN, 1995). Observando este cenário, a equoterapia se destaca como uma prática terapêutica interdisciplinar que utiliza o cavalo como agente de promoção da saúde física, emocional e social. De acordo com CIRILLO (1991 apud FREIRE, 1999, p. 31), “a equoterapia é um tratamento de reeducação reabilitação motora-mental através da prática de atividades equestres e técnicas de equitação”.

Assim, a contribuição deste trabalho é investigar a integração entre arquitetura inclusiva, adequação sensorial, funcionamento da equoterapia e bem-estar animal. Pretende-se compreender como aspectos como implantação, setorização, fluxos, iluminação, acústica, materialidade, transições espaciais e relação com a natureza podem orienta a concepção de ambientes mais adequados à prática terapêutica.

Como resposta projetual, propõe-se um Centro de Equoterapia Inclusiva concebido desde sua origem para essa finalidade, buscando articular acessibilidade, organização dos fluxos, conforto ambiental, contato com a natureza e necessidades dos praticantes, profissionais e cavalos, contribuindo para a discussão sobre espaços terapêuticos inclusivos e sobre o papel da arquitetura como suporte ao cuidado, à autonomia, à inclusão e ao bem-estar.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Projetar um Centro de Equoterapia Inclusiva destinado a crianças e jovens, integrando terapia assistida por cavalos e atividades equestres em espaços acessíveis e adequados às diferentes necessidades físicas e sensoriais dos usuários, que valorize a relação homem-cavalo promovendo o bem-estar animal por meio da arquitetura.

3.1.2 Objetivos Específicos

a) Investigar as necessidades espaciais, funcionais e sensoriais dos praticantes da equoterapia, identificando suas implicações na organização dos ambientes terapêuticos;
b) Analisar os princípios do desenho universal e da arquitetura inclusiva, buscando sua aplicação na concepção de espaços acessíveis, seguros e adequados;
c) Estudar as necessidades comportamentais e ambientais dos cavalos, identificando características arquitetônicas relacionadas ao manejo, à permanência, à circulação e ao bem-estar animal;
d) Compreender os fluxos e as relações espacial entre praticantes, profissionais, acompanhantes e cavalos, visando à organização funcional e segura dos ambientes;
e) Estabelecer diretrizes projetuais que integram acessibilidade, adequação sensorial, conforto ambiental e relação com a paisagem, orientando a concepção de um Centro de Equoterapia Inclusiva.

4 RECORTE DA REVISÃO DA LITERATURA

Os estudos sobre arquitetura e saúde demonstram que as características do ambiente construído podem influenciar a experiência de cuidado. Nos hospitais da Rede Sarah, Lelé incorporou iluminação natural, ventilação e jardins aos espaços de reabilitação, estabelecendo relações entre conforto ambiental e atendimento aos usuários (LIMA, 2012). Essa abordagem dialoga com Kaplan (1995), que investiga os benefícios restauradores do contato com a natureza, especialmente na recuperação da atenção e na redução da fadiga mental. Enquanto Lelé apresenta soluções arquitetônicas aplicadas a equipamentos de saúde, Kaplan oferece fundamentos da psicologia ambiental que ajudam a compreender a importância dessas escolhas espaciais. Gesler (1992) amplia essa leitura ao propor a noção de paisagem terapêutica, na qual o potencial de cura de um lugar resulta da integração entre suas dimensões físicas, sociais e simbólicas. Essa perspectiva fundamenta, neste trabalho, a compreensão do ambiente como parte do processo terapêutico, e não apenas como local onde ele ocorre.

Essa discussão se amplia quando consideradas as diferentes formas de percepção do ambiente. Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) abordam a acessibilidade espacial a partir das condições de orientação, comunicação, deslocamento e uso. Mostafa (2014), por sua vez, aprofunda a relação entre arquitetura e autismo, destacando aspectos como acústica, sequência espacial, transições e organização dos estímulos sensoriais. As duas abordagens se complementam ao demonstrar que a inclusão não depende apenas da eliminação de barreiras físicas, mas também de ambientes compreensíveis e adequados às particularidades dos usuários.

Na arquitetura equestre, Hartmann, Søndergaard e Keeling (2012) evidenciam a importância das condições de alojamento e do contato social para o bem-estar dos cavalos. Essas necessidades acrescentam outra dimensão ao planejamento dos centros de equoterapia, nos quais a organização dos espaços deve conciliar o manejo animal com a acessibilidade e a segurança dos praticantes. Soma-se a isso a questão da implantação, discutida por Santos e Ferraz (2021), uma vez que a necessidade de áreas amplas e contato com a natureza deve ser equilibrada com as condições de acesso das famílias.

Embora essas pesquisas ofereçam contribuições relevantes, abordam predominantemente aspectos específicos da experiência humana, das condições

ambientais ou do comportamento equino. Nesse contexto, o presente trabalho busca articular esses conhecimentos na definição de diretrizes arquitetônicas que integrem desenho universal, adequação sensorial, organização funcional e bem-estar animal, investigando o ambiente como suporte à prática equoterápica.

5 CONCEITOS ESTRUTURANTES DA PROPOSTA

5.1 Equoterapia

A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo a partir de uma abordagem interdisciplinar, voltada ao desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou necessidades especiais. Um de seus principais recursos é o movimento tridimensional produzido pelo passo do cavalo, capaz de transmitir estímulos ao praticante e contribuir para aspectos relacionados ao equilíbrio, à postura e à coordenação (ANDE-BRASIL). Como conceito estruturante, a equoterapia orienta a organização do programa arquitetônico, envolvendo áreas de atendimento, preparação, montaria, percursos terapêuticos e espaços destinados à equipe multiprofissional. Dessa forma, os ambientes são organizados a partir das etapas que compõem a experiência do praticante.

5.2 Desenho universal

O conceito de Desenho Universal foi desenvolvido pelo arquiteto norte-americano Ronald Mace a partir da compreensão de que ambientes e produtos devem ser concebidos para atender ao maior número possível de pessoas, independentemente de idade ou capacidade, reduzindo a necessidade de adaptações posteriores (MACE, 1985). Essa perspectiva amplia a acessibilidade ao incorporá-la desde a concepção do projeto, em vez de tratá-la como uma adequação realizada posteriormente. No campo da arquitetura, Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) complementam essa discussão ao abordar a acessibilidade espacial a partir das condições de orientação, comunicação, deslocamento e uso dos ambientes. Em um centro de equoterapia, esses princípios envolvem não apenas rampas, dimensões e demais exigências normativas, mas a criação de percursos compreensíveis, seguros e acessíveis desde a chegada ao equipamento até os espaços de atendimento, preparação e montaria. Assim, o Desenho Universal orienta uma arquitetura capaz de proporcionar maior autonomia e participação aos diferentes usuários.

5.3 Bem-estar animal

O cavalo, além de participar da terapia, possui necessidades próprias que devem ser consideradas pela arquitetura. Por ser um animal social e sensível às condições ambientais, fatores como confinamento, isolamento e manejo podem

influenciar seu comportamento e nível de estresse (HARTMANN et al., 2012). Assim, ventilação, iluminação natural, áreas de permanência, circulação segura e possibilidade de contato social entre os animais tornam-se decisões projetuais. O bem-estar do cavalo relaciona-se também à segurança e à qualidade das atividades realizadas com os praticantes.

5.4 Articulação: ambiente co-terapêutico

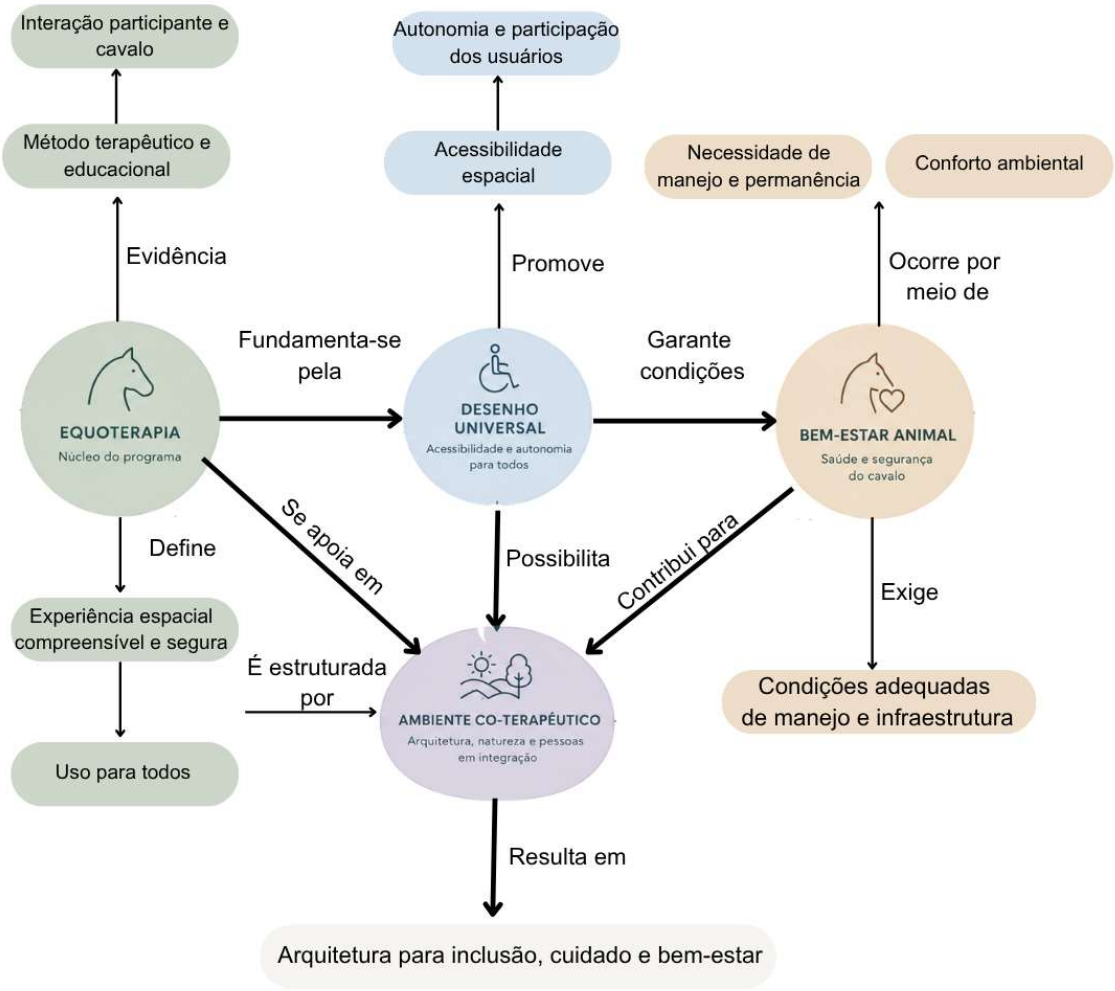
A articulação entre equoterapia, desenho universal e bem-estar animal evidencia a necessidade de uma arquitetura que considere, de forma integrada, as particularidades dos praticantes e dos cavalos. Enquanto a equoterapia estabelece as demandas funcionais da atividade, o desenho universal orienta a acessibilidade e a autonomia dos usuários, e o bem-estar animal incorpora as condições adequadas de manejo, permanência e circulação dos cavalos. Essa relação exige decisões projetuais que conciliem diferentes necessidades, especialmente na organização dos fluxos, no controle dos estímulos sensoriais e nas transições entre ambientes. Nesse contexto, o ambiente co-terapêutico é compreendido como um espaço que não apenas abriga a terapia, mas oferece condições arquitetônicas favoráveis à sua realização, integrando acessibilidade, conforto ambiental, natureza e bem-estar animal.

6. SÍNTESE INTERPRETATIVA

Os conceitos apresentados orientam a investigação ao compreender o Centro de Equoterapia Inclusiva como um espaço em que praticante, cavalo e atividade terapêutica precisam ser considerados de forma integrada. A equoterapia define o núcleo do programa e as exigências da sessão, que depende da interação segura entre o praticante, a equipe multiprofissional e o animal. O desenho universal amplia a análise para além da acessibilidade física, incorporando autonomia, orientação, percepção e conforto dos usuários, inclusive das famílias que acompanham o atendimento. O bem-estar animal, por sua vez, insere o cavalo nas decisões arquitetônicas, exigindo atenção às condições de manejo, permanência e circulação, já que um animal estressado compromete a segurança e a eficácia da terapia.

Essa articulação dialoga diretamente com o problema identificado: o de centros que funcionam em estruturas concebidas para outros usos e adaptadas posteriormente à equoterapia. Nesses casos, podem surgir cruzamentos entre os fluxos de praticantes e animais, percursos dependentes de soluções improvisadas e um conforto ambiental tratado como questão secundária. Assim, a investigação busca compreender como implantação, fluxos, transições, conforto ambiental e relação com a paisagem podem orientar uma arquitetura pensada, desde a origem, para as particularidades da prática equoterápica.

7. DIAGRAMA CONCEITUAL



Fonte: elaboração própria (2026), com base nas referências.

REFERÊNCIAS

ANDE-BRASIL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA. **Equoterapia**. Brasília: ANDE-BRASIL, [s.d.]. Disponível em: https://equoterapia.org.br/articles/index/articles_list/138/81/0. Acesso em: 05 de outubro de 2026

ANDE-BRASIL – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA. **Centros filiados**. Brasília: ANDE-BRASIL, 2026. Disponível em: https://equoterapia.org.br/submit_forms/index/miid/148/a/us/sfid/3. Acesso em: 05 de outubro de 2026

BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 2015.

BRASIL. Lei nº 13.830, de 13 de maio de 2019. Dispõe sobre a prática da equoterapia. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, 14 maio 2019.

DISCHINGER, Marta; BINS ELY, Vera Helena Moro; PIARDI, Sonia Maria Demeda Groisman. **Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos**: programa de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas edificações de uso público. Florianópolis: MPSC, 2012.

FREIRE, Heloisa Bruna Grubits. **Equoterapia**: teoria e técnica: uma experiência com crianças autistas. São Paulo: Vetor, 1999.

FREITAS, Victor Lopes Cançado de Oliveira. **Arquitetura equestre**: projetando conforto e bem-estar para cavalos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023.

HARTMANN, Elke; SØNDERGAARD, Eva; KEELING, Linda J. Keeping horses in groups: a review. **Applied Animal Behaviour Science**, v. 136, n. 2-4, p. 77-87, 2012. DOI: 10.1016/j.applanim.2011.10.004.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Autismo**. Rio de Janeiro: IBGE Educa, 2025. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/criancas/voce-sabia/23216-autismo.html. Acesso em: 1 out. 2026.

KAPLAN, Stephen. The restorative benefits of nature: toward an integrative framework. **Journal of Environmental Psychology**, v. 15, n. 3, p. 169-182, 1995. DOI: 10.1016/0272-4944(95)90001-2.

KUNTZEL, Luana. **O esporte equestre na formação do desenvolvimento de crianças**. 2025. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) –Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2025.

LIMA, João Filgueirade. **Arquitetura**: uma experiência na área da saúde. São Paulo: Romano Guerra, 2012.

MACE, Ronald. Universal design: barrier free environments for everyone. **Designers West**, Los Angeles, v. 33, n. 1, p. 147-152, 1985.

MOSTAFA, Magda. Architecture for autism: Autism ASPECTSS™ in school design. **Archnet-IJAR**: International Journal of Architectural Research, v. 8, n. 1, p. 143-158, 2014.

SANTOS, Ana Karolina Santana; FERRAZ, Priscilla Sandes. Arquitetura x autismo: desafios da inclusão em centros equoterápicos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e76101421793, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21793.

GESLER, Wilbert M. Therapeutic landscapes: medical issues in light of the new cultural geography. **Social Science & Medicine**, v. 34, n. 7, p. 735-746, 1992. DOI: 10.1016/0277-9536(92)90360-3.

SANTOS, Ana Karolina Santana; FERRAZ, Priscilla Sandes. Arquitetura x autismo: desafios da inclusão em centros equoterápicos. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 14, e76101421793, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i14.21793.